中国成年人健康生活方式的日常实施

证据基础、行为条件与情境化实践框架

2026年11月12日 • 学术修订稿

摘要

【目的】分析中国成年人健康生活方式的日常实施条件，提出兼顾身体健康、心理福祉与现实资源约束的情境化实践框架。

【资料与方法】定向检索并查阅中国官方健康文件、食品营养标签标准、国际组织指南及相关原始研究，按规范建议、干预效果和行为理论组织证据，以能力—机会—动机模型分析工作、饮食、睡眠和家庭照护四类情境。

【主要论点】健康素养监测与生活方式干预研究分别提供健康素养水平和健康结局方面的证据，其结果不能相互替代。健康行为的实施还涉及活动时间、食品供给、任务安排及社会支持等条件。场景分析据此将行为目标分解为实施策略、资源要求与评价指标。

【结论】健康生活方式的推广需要同时考虑个体能力与外部实施条件，并分别评价行为变化、健康结局和参与负担。所提出的实践框架及附录方案属于待验证的应用设计，其有效性与可推广性仍需经验研究。

关键词：健康生活方式；健康素养；行为改变；心理健康；时间成本；健康公平



日常生活情境示意（AI生成插图）

健康行为的实施问题与证据范围

健康生活方式的公共倡导涉及合理膳食、身体活动、睡眠、心理健康及烟酒相关风险等多个领域。[1] 相关建议进入日常生活时，需要转换为具体行为，并与工作、学习和家庭照护的时间安排相协调。因此，实施问题不仅涉及健康知识的掌握，也涉及行为发生的条件。

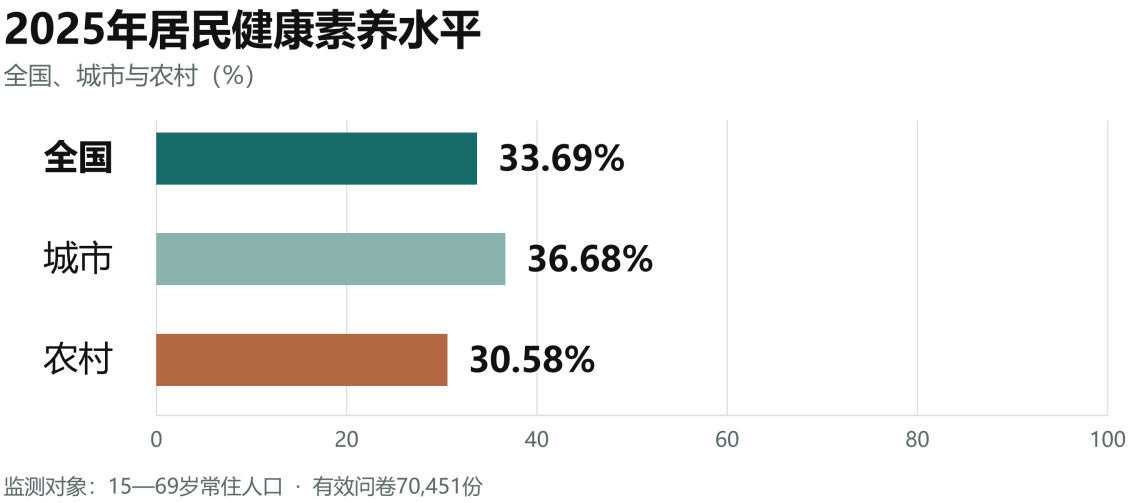


图1 2025年中国居民健康素养水平。调查对象为15—69岁常住人口，有效问卷70451份。[2] 全国、城市和农村使用同一指标；全国估计值并非后两者的简单平均。公开资料未提供置信区间。

2025年中国居民健康素养水平为33.69%，较2024年提高1.82个百分点。[2] 该指标不能直接表示健康生活方式的实施比例。WHO报告的2022年全球成年人身体活动不足比例约为31%，属于不同人群中的行为指标。[3] 两类资料应分别解释，不能据此估计个体层面的知识—行为差距。

1.1 资料来源与分析方法

资料检索与查阅截至2026年11月12日，主要来源包括中国卫生行政部门、国家标准发布机构、WHO及原始论文。文献按问题相关性和来源可核验性定向选择，分为规范性建议、干预效果证据与行为理论三类，未开展穷尽性数据库检索或定量合并。

研究对象限定为普通成年人健康行为的日常实施。四类场景、营养标签算例和附录日程均为分析性设定；其中的时间和任务分配用于说明实施方式，不作为实际调查结果或统一干预剂量。

生活方式干预的效果及适用范围

随机试验可用于评估具体干预对健康结局的影响。美国糖尿病预防项目在血糖升高且超重的高风险成年人中发现，包含个别化课程与持续支持的强化生活方式干预降低了随访期内糖尿病的发生。[4] 这一结果支持的是完整干预方案，不能将其效果归因于单一行为建议。

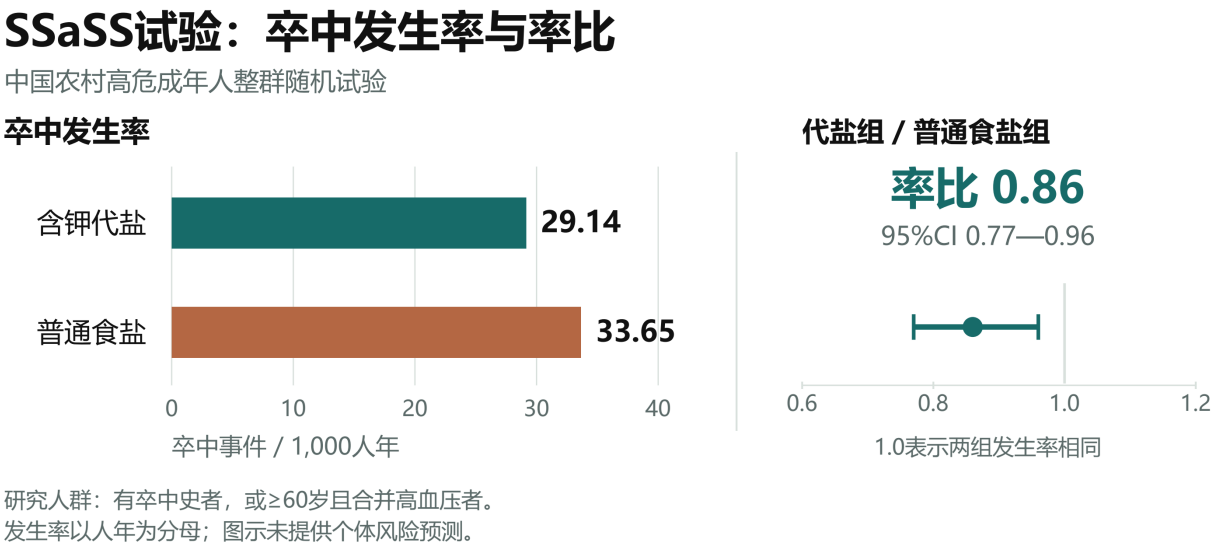


图2 SSaSS整群随机试验的卒中发生率与率比。[5] 研究纳入中国农村20995人，平均随访4.74年；入选对象为有卒中史者，或年龄≥60岁且合并高血压者。

SSaSS试验中，代盐组与普通食盐组的卒中发生率分别为29.14和33.65/1000人年，率比为0.86（95%置信区间：0.77—0.96）。[5] 人年发生率以观察时间为分母，应与一定时期内的累积风险相区分。上述结果也不足以直接估计普通低风险成年人的个体获益。

2.1 从干预效果到实施条件

两项试验所涉及的干预内容、对象和结局不同，不能进行直接效果比较。其共同的实施特征是将行为要求与支持条件结合：前者提供教育和后续支持，后者改变日常食盐的供给与使用。由此可提出实施研究问题：在常规生活条件下，哪些支持能够降低行为执行的困难？

含钾代盐的适用性仍需结合疾病和用药情况评估。试验结果支持特定干预的效果，但不足以验证下文所提出的多领域实践框架。

行为条件、资源约束与评价维度

能力—机会—动机模型（COM-B）将行为理解为能力、机会与动机相互作用的结果。[6] 能力包括完成行为所需的知识、技能和身体条件；机会涉及物理环境与社会条件；动机涵盖反思性判断及自动化过程。该模型用于组织障碍分析，不提供本文场景中各因素的效应量。



图3 基于COM-B的实施分析流程。上部为原模型的三个分析维度；下部为依据该模型提出的策略选择与过程评价步骤，不表示经检验的因果路径。[6]

分析维度	情境中的具体条件	对应的评价内容
能力	营养标签换算、活动强度识别	理解准确性与操作可行性
机会	可用时段、活动空间、照护替代	时间占用、资源可及性与支持
动机	行为目标、价值判断、既有习惯	行动意向、目标认同与习惯相关表征

3.1 健康价值与资源分配

本框架将身体功能、心理福祉和生活参与作为健康行为的目的，并将可接受的参与负担作为实施条件。此处属于规范性立场，其依据不同于临床效果证据。工作产出可以作为特定研究的评价结果，但不足以单独代表健康行为的价值。

时间约束通过改变行为机会进入框架。相同的活动目标，在通勤、家务和照护安排不同的人群中可能产生不同负担。因此，实施评价需要记录资源由谁投入、任务由谁承担，以及调整是否将额外劳动转移给其他家庭成员。

办公与学习情境中的活动安排

情境设定

日间以连续会议、课堂学习或电脑操作为主，午间与任务转换时段具有一定弹性，集中锻炼时段较少。分析目标为减少连续久坐，并逐步增加符合相应强度要求的身体活动。

WHO建议18—64岁成年人每周进行150—300分钟中等强度或75—150分钟高强度有氧活动，或两者的等效组合，并每周至少2天进行肌肉强化活动。[7] 实施安排需要区分减少久坐与达到有氧活动推荐量，分别记录两类行为。

实施要素	具体安排与评价
可用时段	将午餐结束或任务转换作为活动节点，记录该时段是否实际可用。
初始活动	以熟悉、安全路线上的10分钟步行为示例；观察耐受与重复执行情况。
强度识别	中等强度通常允许交谈但难以唱歌，可作为粗略判断；计量时记录实际强度。[8]
替代条件	雨天采用安全的室内路线；临时任务出现时调整时段，记录未执行的原因。



图4 工作学习情境的活动节点示意。节点由任务结构确定，10分钟仅为起始安排的示例；图示未规定统一的久坐中断间隔。

评价时可分别记录有氧活动的强度与分钟数、连续久坐中断情况及不适反应。短暂起身所改变的是久坐模式；仅在活动达到相应强度时，才计入该强度的有氧活动量。具体实施还取决于空间安全性、身体能力和单位或学校的时间安排。

外购餐食与营养标签的应用



图5 主食、蔬菜与鱼肉蛋豆类的餐食搭配示意。AI生成插图，食物数量不表示推荐份量或能量需求。

在主要依赖外购餐食的情境中，选择空间受到预算、供餐种类与份量的约束。依据食物多样和少盐少油等膳食原则，可将实施目标具体化为主食、蔬菜和蛋白质食物的组合，以及酱汁分装、饮水选择等可观察行为。[9]

4.2.1 钠含量与实际食用量

假设标签及使用量	钠含量	占钠NRV的比例
每100克调味料	3000毫克	150%
实际使用10克	300毫克	15%
实际使用20克	600毫克	30%

表1 调味料钠含量换算示例。产品及其含量均为假设，计算基准为GB 28050—2011中钠的营养素参考值（NRV）2000毫克。[10]

实际摄入量按“标签含量×使用量÷标签基准量”计算。例如，3000毫克×10克÷100克＝300毫克。NRV%表示相对于标签参考值的比例；个体钠摄入评价还需计入同日其他食物及调味料。WHO建议一般成年人每日钠摄入少于2000毫克，约相当于盐少于5克。[11]

本节依据GB 28050—2011进行标签演算；GB 28050—2025的实施日期为2027年3月16日。[10, 12] 标签解释应注明所依据标准及适用时间。

4.2.2 可行性与观察指标

情境评价可记录餐食构成、酱汁使用方式、额外支出及选择可获得性。酱汁分装可以改变用量控制条件，但仅有该行为的记录，尚不足以量化总钠摄入的变化。

晚间任务与睡眠机会的配置

情境设定

次日需在固定时间起床，晚间仍存在工作收尾、家务和屏幕娱乐活动。分析对象为可用于睡眠的时间及其稳定性。

国内2025年睡眠健康核心信息将成年人一般睡眠时间表述为7—8小时，并强调个体差异；AASM/SRS共识建议18—60岁成年人规律地每晚睡眠至少7小时。[13, 14] 两者的目标人群与表达方式应分别说明，睡眠评价还需考虑质量、规律性和日间功能。

21:45
工作收尾与待办记录

22:00
低刺激休闲活动

22:30
洗漱及睡前准备

23:00
预留睡眠时间

图6 次日7:00起床条件下的晚间安排示例。23:00至7:00构成8小时睡眠机会；实际睡眠时长仍受入睡潜伏期及夜间觉醒影响。

主要限制	实施策略与评价
任务延续至深夜	明确必要任务及可顺延事项；记录任务结束时间与睡眠机会的变化。
轮班或下班时间不稳定	依据班次安排睡眠，评价休息时段的可预测性，而非采用统一早起时间。
夜间照护频繁	明确照护分工和替代支持，记录中断频次及未被分担的任务。
睡眠机会充分但仍存在困扰	结合持续时间与日间功能寻求专业评估，区分作息安排与临床诊疗。

该情境的实施重点是任务安排与睡眠机会，而非将入睡本身设定为必须按时完成的任务。过程记录可包括就寝和起床时间、主观睡眠质量、日间困倦及晚间任务延迟；持续失眠或明显日间功能受损需要进一步评估。[13]

家庭照护、社会支持与心理福祉

家庭照护情境中的健康行为安排，需要考虑家务、照护与休息时间的分配。以双职工家庭晚间共同承担清洁、儿童照护及次日准备为例，新增活动若缺乏任务调整，可能增加既有安排的冲突。分析重点因而包括任务边界、替代照护和个人休息时段。

任务类型	分配示例	观察内容
餐后整理	成员甲承担厨房收尾	任务范围、用时及临时增加事项
儿童照护与次日准备	成员乙承担约定事项	完成情况及后续协调时间
个人休息	双方分时休息 由另一方接替照护	休息是否被中断及安排的可接受性

表2 家庭任务分配的情境示例。成员代号不对应性别；任务分配用于说明协商内容，不构成适用于所有家庭的分工模式。

4.4.1 支持的结构、功能与质量

WHO的社会连接框架区分关系结构、支持功能和关系质量。[15] 因此，心理与社会支持的评价不宜仅采用联系人数，还应关注帮助的可获得性、表达需要的条件及互动质量。独处状态与主观孤独感应分别考察。

单亲家庭、承担失能长者照护或缺乏替代支持的家庭，资源条件与上述示例不同。对这些情境的分析需要进一步考察亲友支持、社区服务和专业照护的可及性，并计入无酬劳动与协调成本。

4.4.2 工作条件与专业支持

WHO工作场所心理健康指南涵盖组织干预、管理者与员工培训、个人支持及返岗安排。[16] 由此，工作相关心理健康问题的实施分析应同时涉及任务要求、工作安排和支持条件。持续加重或影响日常功能的心理困扰，应结合专业评估处理。[1]

实施评价、健康公平与研究局限

5.1 从行为执行到健康结局

四类情境说明，同一健康目标需要根据任务结构和资源条件形成不同实施策略。后续研究可检验：在健康教育内容相近的条件下，增加时间安排或资源支持，是否提高行为维持程度；其效应是否因照护负担、工作弹性及资源可及性而异。这些属于由框架引出的研究假设。

评价应区分过程指标、健康结局和实施负担。前者包括行为执行、持续时间与中断后的恢复执行；健康结局涉及身体功能、心理福祉及相应疾病指标；实施负担涉及时间、费用和不良体验。各维度宜分别报告，避免将未经验证的综合分数作为唯一结局。

5.2 资源分配与经济评价

成本效果、支出节省和预算可承受性回答不同问题。经济评价需明确比较方案、分析视角、时间范围、成本与健康结果，并报告不确定性；CHEERS 2022可用于规范报告。[17] 家庭无酬劳动和协调时间应按分析视角考虑，避免同一时间损失被重复计量。本文尚未开展经济评价，无法判断所提方案的成本效果。

5.3 局限

本研究采用定向叙述性综合，文献选择可能存在偏倚，且未对纳入资料进行系统质量评级。部分论据依据官方概览或原始摘要，限制了对干预细节的分析。高风险人群试验的结果不能直接外推至普通成年人；四类场景和附录方案也缺乏实际实施数据。

本框架聚焦日常实施条件，未覆盖全部预防与医疗服务。疫苗接种、风险分层筛查、规范就医与用药仍需按个人情况安排；避免吸烟和二手烟暴露、避免为健康目的开始饮酒同样属于相关健康建议。[1,18]

5.4 结论

中国成年人健康生活方式的日常实施，应在健康知识与行为目标之外，明确能力、机会和动机条件，并评价参与负担及其分配。情境化框架提供了组织实施问题的分析方式，其对行为维持和健康结局的影响仍需前瞻性研究检验。

参考文献

按正文首次引用顺序编码；网络资料访问日期为2026年11月12日。

[1] 国家卫生健康委办公厅. 中国公民健康素养——基本知识与技能（2024年版）[EB/OL]. (2024-05-28)[2026-11-12].

原文链接

[2] 国家卫生健康委员会. 2025年全国居民健康素养水平达到33.69%[EB/OL]. (2026-01-07)[2026-11-12].

原文链接

[3] World Health Organization. Physical activity[EB/OL]. (2026-11-04)[2026-11-12].

原文链接

[4] Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin[J]. New England Journal of Medicine, 2002, 346(6): 393–403. DOI: 10.1056/NEJMoa012512.

原文链接

[5] Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death[J]. New England Journal of Medicine, 2021, 385(12): 1067–1077. DOI: 10.1056/NEJMoa2105675.

原文链接

[6] Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions[J]. Implementation Science, 2011, 6: 42. DOI: 10.1186/1748-5908-6-42.

原文链接

[7] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour[M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2020[2026-11-12].

原文链接

[8] Centers for Disease Control and Prevention. How to measure physical activity intensity[EB/OL]. (2025-12-04)[2026-11-12].

原文链接

[9] 中国营养学会. 《中国居民膳食指南（2022）》平衡膳食八准则[EB/OL]. (2022-04-26)[2026-11-12].

原文链接

[10] 中华人民共和国卫生部. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则：GB 28050—2011[S/OL]. 2011[2026-11-12].

原文链接

参考文献

[11] World Health Organization. Sodium reduction[EB/OL]. (2026-05-11)[2026-11-12].

原文链接

[12] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则：GB 28050—2025[S/OL]. 2025[2026-11-12].

原文链接

[13] 全国爱卫办. 睡眠健康核心信息及释义[EB/OL]. 2025[2026-11-12].

原文链接

[14] Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society[J]. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2015, 11(6): 591–592. DOI: 10.5664/jcsm.4758.

原文链接

[15] World Health Organization. Social connection[EB/OL]. (2025-06-30)[2026-11-12].

原文链接

[16] World Health Organization. WHO guidelines on mental health at work[M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2022[2026-11-12].

原文链接

[17] Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement: updated reporting guidance for health economic evaluations[J]. BMJ, 2022, 376: e067975. DOI: 10.1136/bmj-2021-067975.

原文链接

[18] World Health Organization. Alcohol[EB/OL]. (2024-06-28)[2026-11-12].

原文链接

[19] Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, et al. How are habits formed: modelling habit formation in the real world[J]. European Journal of Social Psychology, 2010, 40(6): 998–1009. DOI: 10.1002/ejsp.674.

原文链接

资料与图像说明

本文未收集原创受试者数据。场景、标签算例及附录日程为分析性示例；统计图依据所引文献的公开数值绘制。两张情境插图由OpenAI内置图像生成工具生成。ChatGPT/Codex用于资料辅助整理、语言编辑、图表绘制与排版。

辅助工作流文献：Kassis T, Agarwal V, He Y, et al. Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. 2026. arXiv:2609.00065.

每周身体活动的时间分配

本示例适用于身体条件允许且能够耐受相应活动的成年人，用于展示每周中等强度有氧活动的时间配置。星期和时段可以调整；起始活动量应结合既往活动水平及身体能力确定。

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	30 分钟 中等强度 有氧活动	弹性 休息或 合适的活动	弹性 休息或 合适的活动

30分钟 × 5天 = 150分钟

肌肉强化安排：周二、周六；具体内容依据身体能力确定。

附图A1 每周活动时间分配示例。周一至周五每天30分钟，共150分钟中等强度有氧活动；肌肉强化另在周二、周六安排，不以其时长替代有氧活动量。[7]

实施限制	调整方式	过程记录
可用时间分散	将部分活动拆分为较短时段	各时段的实际强度与持续时间
临时加班或照护任务	调整至后续可行时段，必要时减少活动量	变动原因、睡眠与任务冲突
体能不足或既往活动较少	从较低活动量逐步增加	耐受、不适反应及恢复情况

WHO指南强调少量活动优于不活动，并建议限制久坐。[7] 因而，评价宜同时记录活动量的变化及与推荐量的差距，避免将未达到推荐量的活动等同于无活动。孕期、慢性病或功能受限情境需要参照相应建议作进一步适配。

记录项目

建议记录活动类型、强度、持续时间及主要限制条件。相关记录服务于日程调整，不构成训练处方；明显不适或活动能力异常变化需结合专业评估。

十二周观察安排与记录表

以下分期用于组织行为观察与安排调整，不表示已验证的干预周期。既有习惯形成研究提示，行为自动化过程存在个体差异，不能据单一平均或中位时长规定统一达标期限。[19]

阶段	实施任务	评价依据
第1—2周	记录初始情况，确定一项优先行为	可执行性、发生情境与现有负担
第3—4周	调整准备步骤与主要限制条件	准备时间、资源支持与执行变化
第5—8周	依据执行情况与可用资源调整实施安排	执行情况、精力、情绪与参与负担
第9—12周	观察任务变化及中断后的恢复执行	维持情况、调整原因与后续安排

每周过程记录

目标行为及发生情境

实际执行情况与体验

主要限制条件

下周拟调整事项

所需支持及后续时段

记录频次可按实际需要调整。每周一次属于可行性示例，评价重点是行为、条件和负担之间的变化关系。行为中断后的恢复执行可作为探索性过程指标，其对长期健康结局的预测价值尚待研究。

分期安排不要求通过过量运动、补偿性节食或减少睡眠弥补未完成事项。记录用于调整实施条件，涉及心理或家庭信息时应由记录者自行管理，并避免不必要的披露。